語 聲 山 語

長輩溝通與吞嚥檢核表

家屬版・四大面向

吞嚥安全 ・ 說話與找詞 ・ 記憶與表達 ・ 聲音與音量

怎麼用這份表

1. 可由長輩本人填寫，或由最常陪伴的家人代填。**「記憶與表達」那一區由家人代填會比較準確。**
2. 時間範圍為**最近半年，有出現的情況才勾選，沒有則留空。**判斷基準是「與他以前相比是否有變化」，而不是與他人比較。
3. 四個區塊，你可以只填在意的那一區，也可以全部填完。
4. 勾選完成後翻到「判讀說明」，對照結果決定下一步。就診時直接交給醫師。

本表不是 EAT-10，也不是 AD-8 的中文版。那兩份量表分別受 Société des Produits Nestlé S.A.[7] 與美國聖路易華盛頓大學[12] 的著作權保護，本站尊重其授權，未轉載其中任何一題。本表題目由語聲山語自行撰寫，依據為美國聽語學會（ASHA）成人吞嚥困難臨床指引[3]、美國阿茲海默症協會的早期警訊[9] 等研究文獻。

本表用於協助你整理日常觀察，並非診斷。

填表前先確認：這些是要立刻打 119 的中風警訊

若長輩**此刻或最近數小時內**突然出現下列任一項，請先不要填寫本表，立即記下症狀開始的時間並撥打 119。國民健康署與台灣腦中風學會推廣的口訣為「**臨微不亂**」[1]：

- **臨**時手腳軟：**單側**手腳突然無力、舉不起來。
- **微**笑也困難：臉部表情不對稱、**嘴角歪斜**。
- 講話**不**清楚：突然口齒不清、講不出話，或聽不懂別人說什麼。
- 國際上的 B.E. F.A.S.T. 另加兩項：突然**失去平衡、走路不穩**，或突然**視力模糊**[2]。
- 別**亂**：出現上述任一徵兆，**先記下症狀開始的時間，立即撥打 119**[1]。發作時間會直接影響能否接受血栓治療。

檢核題目

☐ 有出現的情況才勾選，沒有則留空。　　標示 ★ 者為該區關鍵題，勾選到即建議安排評估。右上角 [數字] 為文末參考文獻編號。

1. 吞嚥安全

喝水會嗆、吞藥困難、體重下降 ・ 共 8 題

吞嚥功能變差時，最先出現的往往是「吃飯變得麻煩」，而不是明顯的嗆到。請依最近半年的情況勾選。

☐ 1. 喝水或喝湯時會嗆到、咳嗽[3]

☐ 2. 吃一頓飯的時間比以前明顯拉長，或需要特別費力咀嚼[3]

☐ 3. 吃完東西後，聲音變得濕濕、濁濁的[3]

☐ 4. 覺得食物「卡在喉嚨」，或吞不太下去[3]

☐ 5. 吞藥丸變得困難，需要磨粉、剝半或配果凍才吞得下[8]

☐ 6. 吃東西時，食物或湯汁會從嘴角流出來[3]

☐ 7. 最近半年沒有刻意減重，體重卻下降；或因為吃不夠而脫水[3]

☐ 8. 最近一年曾因為發燒、肺炎或呼吸道感染就醫或住院[3,4] ★

2. 說話與找詞

中風後、找不到字、聽不懂 ・ 共 6 題

若長輩曾經中風或腦部受過損傷，說話與理解這兩方面的變化特別需要注意。

- [ ] 1. 想說的詞一時找不到，話講到一半就卡住[14]
- [ ] 2. 聽別人說話要花很久才理解，或常常會錯意[14]
- [ ] 3. 說話含糊不清，別人常常要他再說一次[16]
- [ ] 4. 一直重複同一個字或同一句話，停不下來[14]
- [ ] 5. 看字、寫字比以前吃力，例如看不懂帳單或簽名變困難[14]
- [ ] 6. 曾經中風或腦部受傷，之後說話或理解就和以前不一樣了[14,15] ★

3. 記憶與表達

想不起名稱、話題重複、繞圈說話 ・ 共 6 題

失智症早期最常見的語言變化，是「想不起該用哪個詞」與「說話繞圈子」，並非只有忘東忘西。這一區由家人代填會比長輩自填準確。

- [ ] 1. 講到一半突然接不下去，忘了自己剛剛要說什麼[9]
- [ ] 2. 想不起熟悉東西的名稱，改用「那個」「那個東西」代替[9]
- [ ] 3. 用錯名稱，例如把「手錶」說成「手上的鐘」[9]
- [ ] 4. 同一件事、同一個問題，短時間內反覆說很多次[9]
- [ ] 5. 跟不上多人一起的對話，或開始不太願意加入談話[9]
- [ ] 6. 家人覺得他最近一年在記憶或表達上，和以前明顯不一樣[11,13]

4. 聲音與音量

越講越小聲、沙啞、講久沒力 · 共 6 題

聲音變小、變沙啞，常被當成「年紀大了本來就這樣」，但它會讓長輩越來越不願開口，也逐漸減少外出與社交。

- [ ] 1. 講話音量變小，家人常常要他「大聲一點」[16]
- [ ] 2. 聲音變沙啞、變成氣音，或講一陣子就沒力氣[18]
- [ ] 3. 講話速度變快或含在嘴裡，別人聽不清楚[16]
- [ ] 4. 在餐廳、人多的地方幾乎沒辦法和別人交談[18]
- [ ] 5. 因為講話吃力，變得越來越少開口、越來越少出門[18]
- [ ] 6. 已被診斷巴金森氏症，而且說話有上述變化[16,17] ★

判讀說明：什麼情況該找專業評估

四個區塊**各自計算**，不要把四區加總。計算每一區勾選了幾項、是否勾到 ★ 關鍵題，再對照下表。

1. 吞嚥安全

結果	條件	建議怎麼做
目前無警訊	0 項	建議每半年回來檢視一次。吞嚥功能的變化很緩慢，而且不一定會出現嗆咳[6]。
留意觀察	1–2 項且未勾 ★	用餐時坐正、專心進食不邊看電視、一口的量減少、吞下去後再吃下一口。若喝水容易嗆，先請醫師或語言治療師評估是否需要調整食物的軟硬稠度——**不要自行長期將食物全部打成泥**，質地過度限制反而會影響營養攝取與進食意願。1–2 個月沒有改善即安排評估。
建議評估	3 項以上，**或**勾到 ★	掛復健科、耳鼻喉科或神經內科，要求轉介語言治療評估，並帶上本表。吞嚥功能出問題會直接影響營養、導致脫水，也會提高吸入性肺炎與再次住院的風險[4]。若需要居家或社區照顧服務，可撥打 1966 長照專線[20]。

2. 說話與找詞

結果	條件	建議怎麼做
目前無警訊	0 項	若長輩曾經中風，仍建議定期回來確認。
留意觀察	1 項且未勾 ★	記錄出現的情境與頻率（疲累時是否更嚴重）。與他對話時放慢速度、一次只講一件事、說完多等他幾秒回應。情況持續或加重即安排評估。
建議評估	2 項以上，**或**勾到 ★	請神經內科或復健科醫師轉介語言治療。中風急性期出現失語症者約占三成[14]；一份彙整 57 篇臨床試驗的國際大型回顧研究顯示，語言治療對中風後失語症確實有幫助[15]——**中風後的說話問題是可以治療的**。若說話的變化是**突然**發生的，請先回頭確認一次中風警訊[1]。

3. 記憶與表達

結果	條件	建議怎麼做
目前無警訊	0 項	建議每半年回來檢視一次。
留意觀察	1 項	偶爾想不起名字，在任何年齡都可能發生。記錄出現的頻率，3–6 個月後再檢視一次。

建議評估	2 項以上	可掛神經內科或精神科的記憶門診。衛福部推廣的中文版 AD-8 極早期失智症篩檢，可請醫療院所施測[11][12][13]。美國阿茲海默症協會將「說話或書寫用詞出現新的困難」列為十大早期警訊之一[9]。若語言退化明顯早於、且重於記憶問題，請主動向醫師提出「原發性進行性失語症（PPA）」的可能[10]。失智症中後期常合併吞嚥困難，一份統整多篇研究的回顧指出，中重度阿茲海默症患者約有 8 至 9 成出現吞嚥障礙[19]，建議一併完成第 1 區。

4. 聲音與音量

結果	條件	建議怎麼做
目前無警訊	0 項	若日後出現講久了沒力氣或音量變小，再回來檢視一次。
留意觀察	1 項且未勾 ★	多喝水，避免清喉嚨與長時間大聲說話。**沙啞持續超過兩到三週沒有改善，請掛耳鼻喉科檢查聲帶**，不要只當作感冒尚未痊癒。
建議評估	2 項以上，**或**勾到 ★	先由耳鼻喉科檢查聲帶，排除結構上的問題。老化造成的嗓音問題約影響每 10 位長輩中的 1 至 2 位，一份統整多篇研究的回顧指出**嗓音治療是首選的處置方式**[18]。若已診斷巴金森氏症：接近 9 成的患者會出現言語問題[16]，密集嗓音治療（LSVT LOUD）在臨床試驗中顯示，說話音量的改善可維持到治療後 7 個月[17]。

兩件家屬最容易誤會的事

> **一、沒有嗆到，不代表沒有嗆進去。**臨床上有一種情形稱為「無聲吸入」：食物或水已經進入呼吸道，卻完全沒有咳嗽，外觀上也看不出異狀[6]。歐洲吞嚥障礙學會與歐洲老年醫學會共同發表的白皮書也指出，健康長者本來就較容易出現無聲吸入，而且許多長輩並不知道自己的吞嚥功能已經改變[4]。因此「反覆發燒或肺炎」比「有沒有嗆到」更值得警覺。
>
> **二、吞嚥退化不是「老了就這樣」。**吞嚥困難相當常見：自行居住於社區的長輩約每 10 位有 3 至 4 位；住院的高齡病人約每 10 位有 4 位多；機構住民約每 10 位有 6 位[4]。2023 年一份統整多篇研究的分析也顯示，護理之家住民約半數有此問題[5]。但常見不等於只能忍受——它是可以評估、可以調整、也可以治療的。

台灣的長照與就醫管道

1966 長照服務專線。65 歲以上長者、55 歲以上原住民、50 歲以上失智者與失能身心障礙者，可撥打 1966 申請長照服務，亦可洽當地長期照顧管理中心或線上申請。流程為：專員到府評估 → 擬定照顧計畫 → 連結服務單位 → 開始使用服務[20]。目前施行的是長照十年計畫 3.0（民國 115–124 年）[21]。

尋找語言治療服務。吞嚥評估通常先看復健科、耳鼻喉科或神經內科，再由醫師轉介語言治療師。可至 talkingslp.com/clinics.html 查詢全台語言治療院所。

參考資料

1. 衛生福利部國民健康署。〈搶救腦中風 謹記「臨微不亂」〉（與台灣腦中風學會合作推廣）。https://www.mohw.gov.tw/cp-3801-44431-1.html
2. American Stroke Association (AHA). *Stroke Symptoms and Warning Signs (F.A.S.T. / B.E. F.A.S.T.).* https://www.stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms
3. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). *Adult Dysphagia* — Practice Portal（signs and symptoms）。https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/adult-dysphagia/
4. Baijens LWJ, Clavé P, Cras P, et al. ESSD–EUGMS white paper: oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome. *Clin Interv Aging.* 2016;11:1403–1428. DOI: 10.2147/CIA.S107750；PMID: 27785002
5. Rivelsrud MC, Hartelius L, Bergström L, Løvstad M, Speyer R. Prevalence of Oropharyngeal Dysphagia in Adults in Different Healthcare Settings: A Systematic Review and Meta-analyses. *Dysphagia.* 2023;38(1):76–121. DOI: 10.1007/s00455-022-10465-x；PMID: 35639156
6. Ramsey D, Smithard D, Kalra L. Silent Aspiration: What Do We Know? *Dysphagia.* 2005;20(3):218–225. DOI: 10.1007/s00455-005-0018-9；PMID: 16362510
7. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, et al. Validity and Reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 2008;117(12):919–924. DOI: 10.1177/000348940811701210；PMID: 19140539
8. Mc Gillicuddy A, Crean AM, Sahm LJ. Older adults with difficulty swallowing oral medicines: a systematic review of the literature. *Eur J Clin Pharmacol.* 2016;72(2):141–151. DOI: 10.1007/s00228-015-1979-8
9. Alzheimer's Association. *10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer's*（第 6 項 New problems with words in speaking or writing）。https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs
10. Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology.* 2011;76(11):1006–1014. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31821103e6；PMID: 21325651
11. 衛生福利部。〈極早期失智症篩檢〉（中文版 AD-8 說明）。https://www.mohw.gov.tw/cp-3163-28170-1.html
12. Galvin JE, Roe CM, Powlishta KK, et al. The AD8: A brief informant interview to detect dementia. *Neurology.* 2005;65(4):559–564. DOI: 10.1212/01.wnl.0000172958.95282.2a
13. Yang YH, Galvin JE, Morris JC, Lai CL, Chou MC, Liu CK. Application of AD8 Questionnaire to Screen Very Mild Dementia in Taiwanese. *Am J Alzheimers Dis Other Demen.* 2011;26(2):134–138. DOI: 10.1177/1533317510397330
14. Grönberg A, Henriksson I, Stenman M, Lindgren AG. Incidence of Aphasia in Ischemic Stroke. *Neuroepidemiology.* 2022;56(3):174–182. DOI: 10.1159/000524206；PMID: 35320798
15. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, Campbell P. Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;(6):CD000425. DOI: 10.1002/14651858.CD000425.pub4；PMID: 27245310
16. Moya-Galé G, Levy ES. Parkinson's disease-associated dysarthria: prevalence, impact and management strategies. *Res Rev Parkinsonism.* 2019;9:9–16. DOI: 10.2147/JPRLS.S168090
17. Ramig L, Halpern A, Spielman J, Fox C, Freeman K. Speech treatment in Parkinson's disease: Randomized controlled trial (RCT). *Mov Disord.* 2018;33(11):1777–1791. DOI: 10.1002/mds.27460；PMID: 30264896
18. Galluzzi F, Garavello W. The aging voice: a systematic review of presbyphonia. *Eur Geriatr Med.* 2018;9(5):559–570. DOI: 10.1007/s41999-018-0095-6
19. Mira A, Gonçalves R, Rodrigues IT. Dysphagia in Alzheimer's disease: a systematic review. *Dement Neuropsychol.* 2022;16(3):261–269. DOI: 10.1590/1980-5764-DN-2021-0073；PMID: 36619845
20. 衛生福利部長照專區。〈申請長照服務〉（1966 專線、服務對象與流程）。https://1966.gov.tw/LTC/cp-6533-70777-207.html
21. 衛生福利部長照專區。〈長照十年計畫 3.0〉（行政院 114 年 12 月 31 日核定，期程 115–124 年）。https://1966.gov.tw/LTC/cp-6572-85008-207.html

題目撰寫說明：本表所有題目由語聲山語自行撰寫，未重製任何受著作權保護之臨床量表題目。吞嚥區的徵象依據 ASHA 成人吞嚥困難臨床指引所列項目[3]與相關文獻[4][8]；失智語言警訊區參考美國阿茲海默症協會早期警訊第 6 項[9]與 PPA 分類共識[10]。判讀門檻為語聲山語依上述研究文獻訂定的建議值，並非經過驗證的量表切分點。

本檢核表用於協助你整理日常觀察，不是醫療診斷，也不是任何臨床量表的中文版，無法取代語言治療師或醫師的專業評估。若出現中風的急性警訊，請立即撥打 119。
© 2026 語聲山語 語言治療衛教平台 ・ talkingslp.com ・ talkingslptw@gmail.com ・ 歡迎自由列印分享，請保留出處。